

## 27 - L'Accouchement en Présentation de Sommet - Pr. HAROU

(0:02 - 0:17)

Ceci est un cours destiné aux étudiants de 5e année de médecine. Nous allons aborder dans ce cours l'accouchement en présentation de sommets. Nous avons adopté le plan suivant.

(0:18 - 0:43)

Après une brève introduction, nous allons faire quelques rappels anatomiques, puis nous aborderons les diagnostics cliniques puis paracliniques, nous parlerons de la mécanique obstétricale, et nous finirons par une conduite à tenir pratique avant de conclure. La présentation de sommets est la présentation la plus fréquente. Elle concerne 95% des accouchements.

(0:44 - 1:17)

C'est une présentation dite autopsique. Il s'agit d'une présentation céphalique caractérisée par une flexion maximale de la tête, et donc le repère essentiel est l'occipite. Sur le plan rappel anatomique, les éléments de l'accouchement en présentation de sommets sont constitués essentiellement par le bassin obstétrical et l'homobile fœtale, et essentiellement la tête fœtale.

(1:19 - 1:42)

Pour le bassin obstétrical, il est caractérisé par la présence de trois détroits, le détroit supérieur, le détroit moyen, le détroit inférieur. Ces détroits sont caractérisés par leur diamètre. Pour le détroit supérieur, on distingue essentiellement le transverse médian qui est de 12 à 12,5 cm, le diamètre promontorétopubien qui est de l'ordre de 10,5 cm.

(1:42 - 2:12)

Quant au détroit moyen, le diamètre essentiel est le diamètre bislatique, dit biépineux, qui est en moyenne de 11 cm, et le détroit inférieur est caractérisé par le diamètre bislatique qui mesure en moyenne 11 cm. En présentation de sommets, avec le bassin obstétrical interagit le pôle céphalique fœtal. Le pôle céphalique est un ovale à grosse extrémité postérieure.

(2:12 - 2:32)

Il est caractérisé par deux fontanelles, la fontanelle antérieure, dite brégma, et la fontanelle postérieure, dite landa. La présentation de sommets, elle correspond à la flexion maximale de ce pôle céphalique. Elle est caractérisée par le diamètre sous-occipitoprématique qui est de l'ordre de 9,5 cm.

(2:36 - 3:07)

Le diagnostic de la présentation de sommets est essentiellement clinique. Il se fait au cours du

travail. L'examen physique retrouve au palpé abdominal une présentation longitudinal, permet de rechercher le pôle céphalique et le siège, d'apprécier la hauteur utérine, de rechercher le plan du dos par la manœuvre de l'opôle, et l'identification du foyer du bruit cardiaque fœtal.

(3:13 - 3:37)

Le toucher vaginal est l'étape clé de l'examen clinique. Il permet de confirmer le diagnostic, en recherchant le repère de la présentation de sommets qui est la fontanelle postérieure. Cette dernière permet, grâce à sa position, de préciser la variété.

(3:38 - 3:51)

Et on distingue quatre variétés. D'abord, la variété occipito-iliaque gauche antérieure, la plus fréquente, 57% des cas. L'occipito-iliaque droite postérieure, avec 33% des cas.

(3:52 - 4:14)

L'occipito-iliaque gauche postérieure, dont 6% des cas. Et l'occipito-iliaque droite antérieure. Il ne faut pas oublier de signaler certains éléments importants pour le pronostic de l'accouchement, tels que les données de l'examen général, à savoir la tension artérielle, la température, la présence ou non d'endométrites des membres inférieurs.

(4:16 - 4:29)

L'évaluation des contractions utérines avec leur fréquence, durée et intensité. La présence ou non de rupture des membranes. L'appréciation du liquide amniotique avec son aspect, couleur et odeur.

(4:31 - 5:08)

Et à la fin, apprécier le score de Bishop qui évalue la position, l'effacement, la dilatation, la souplesse cervicale, ainsi que la hauteur de la présentation. En ce qui concerne le diagnostic paraclinique, le monitoring obstétrical permet d'apprécier le bien-être fœtal, et l'échographie périnatale peut être utile dans certains cas pour apprécier la variété de la présentation. L'accouchement en présentation de sommet va concerner trois niveaux.

(5:09 - 5:54)

D'abord l'engagement qui concerne le Déroit supérieur, puis la descente-rotation qui se fait au niveau du Déroit moyen, et finalement le dégagement qui se fait au niveau du Déroit inférieur. L'engagement correspond à la traversée du Déroit supérieur par la présentation. Certains phénomènes préparatoires sont de mise, tels que l'orientation de la présentation dans un diamètre oblique, une flexion maximale de la tête qui correspond à la présentation de sommet, un asynclitisme qui peut être antérieur ou postérieur, et dans certains cas un léger chevauchement

des os du crâne.

(5:58 - 6:14)

Le diagnostic de l'engagement se fait essentiellement par le douché vaginal, par le signe de Faraboeuf. On introduit deux doigts dirigés vers le deuxième vertèbre sacré. Ces deux doigts butent quand la présentation est engagée.

(6:18 - 6:34)

La deuxième étape est le franchissement du Détroit moyen. Deux phénomènes à signaler. La descente de la tête qui se fait selon l'axe de l'engagement, et la rotation qui fait correspondre le diamètre sous-occipitoprigmatique à l'axe antéropostérieur du bassin.

(6:39 - 7:12)

La dernière étape correspond au dégagement, ou l'accouchement proprement dit. Durant cette étape, la tête fœtale se défléchit, et le périnée est sollicité. Le dégagement peut se faire soit en occipitopubien, avec une rotation de 45 degrés en variété antérieure, ou de 135 degrés en variété postérieure, ou en occipitosacrée, avec une rotation de 45 degrés, le plus souvent en variété postérieure.

(7:16 - 8:04)

Une fois le diagnostic de la présentation de sommet fait, quelle est la conduite à tenir pratique ? D'abord, il faut rassurer la parturiente et lui fournir les explications nécessaires. Installer la parturiente sur une table obstétricale, l'idée s'avérait, prendre une voie veineuse de sécurité, l'installer en position gynécologique, et puis assurer une synchronisation de la possible mine avec les contractions UTM. Lors de l'accouchement de la tête, il faut éviter l'expulsion rapide de la tête, contrôler le périnée, et après l'expulsion de la tête, assurer la rotation de restitution.

(8:08 - 8:35)

L'accouchement des épaules se fait d'abord par une traction légère vers le bas, pour dégager l'épaule antérieure, puis une traction vers le haut pour dégager l'épaule postérieure. L'accouchement de siège fait suite aux épaules, et la délivrance est un élément aussi important que les autres étapes. Au cours de la présentation de sommet, l'accoucheur intervient durant la phase de dégagement.

(8:38 - 9:25)

Ces différents schémas montrent l'altitude et la position des mains de l'accoucheur face à l'accouchement d'une présentation de sommet en variété antérieure. Les mains, après avoir saisi la tête fœtale, vont faire un mouvement de rotation et de restitution, puis une traction légère vers

le bas permet de dégager l'épaule antérieure, traction légère vers le haut permet de dégager l'épaule postérieure, et puis le siège suivra sans problème. La délivrance est une étape très importante à ne pas oublier.

(9:29 - 9:44)

En conclusion, on peut dire que la présentation de sommet est une présentation autopsique, que le diagnostic se fait au cours du travail, et l'accouchement doit impérativement respecter la mécanique obstétrique. Je vous remercie.